Disproporsi Sefalopelvik

Anandha Mardhia Prefitri

Departemen Obstetri dan Ginekologi
Universitas Hasanuddin

Tujuan pembelajaran

Setelah kuliah ini, mahasiswa mampu:

1. **Menjelaskan** definisi dan klasifikasi CPD
2. **Mengingat kembali** ukuran panggul dan diameter kepala janin yang penting
3. **Mengidentifikasi** penyebab dan faktor risiko dari ibu dan janin
4. **Mendiagnosis** kecurigaan CPD saat antenatal dan intrapartum
5. **Menjelaskan tatalaksana** partus percobaan, seksio sesarea, dan rujukan tepat waktu

1

Konsep dasar

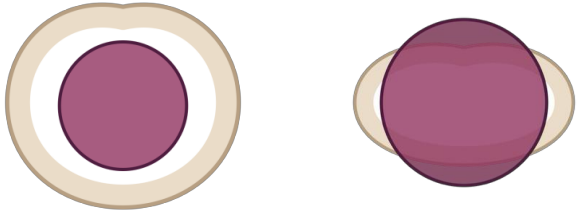
Definisi, tempat CPD dalam distosia, dan klasifikasinya

Apa itu disproporsi sefalopelvik

Definisi

Ketidaksesuaian ukuran kepala janin dengan panggul ibu sehingga kepala tidak dapat melewati jalan lahir

- Salah satu penyebab utama persalinan macet
- Yang dinilai adalah kesesuaian, bukan ukuran panggul saja



Sesuai
Kepala muat melewati pintu panggul

CPD
Kepala lebih besar dari jalan lahir

Skema: pintu atas panggul dilihat dari atas

CPD dalam kerangka distosia



Power

Tenaga

His dan tenaga mengejan ibu



Passage

Jalan lahir

Panggul tulang dan jaringan lunak



Passenger

Janin

Ukuran, presentasi, posisi, dan sikap kepala

CPD = ketidaksesuaian antara passage dan passenger, saat power sudah adekuat

Klasifikasi: absolut dan relatif

CPD absolut (sejati)

- Kepala tidak mungkin lewat walau his baik dan posisi ideal
- Panggul sempit berat atau deformitas panggul
- Janin sangat besar atau hidrosefalus
- Jarang; tatalaksana seksio sesarea

CPD relatif

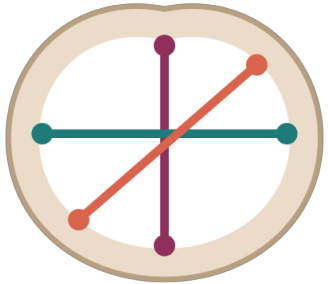
- Ukuran sebenarnya cukup, tetapi diameter yang lewat membesar
- Oksiput posterior, asinklitismus
- Defleksi: presentasi puncak, dahi, muka
- Lebih sering; dapat terkoreksi saat persalinan

2

Anatomi yang perlu diingat

Ukuran panggul, bentuk panggul, dan diameter kepala janin

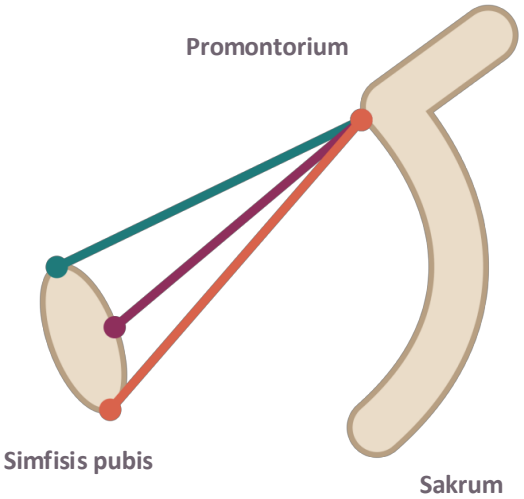
Ukuran panggul yang penting



Anteroposterior (konjugata)
Transversa
Oblik

Ukuran	Normal	Curiga sempit
Konjugata obstetrika	±10,5–11 cm	< 10 cm
Konjugata diagonalis	±12,5 cm	< 11,5 cm
Transversa pintu atas	±13 cm	< 12 cm
Interspinarum	±10,5 cm	< 10 cm
Intertuberosum	±10–11 cm	≤ 8 cm
Arkus pubis	> 90°	< 90°

Tiga konjugata pintu atas panggul



Konjugata vera

Promontorium ke tepi atas simfisis; ±11 cm.

Konjugata obstetrika

Ke titik paling menonjol di belakang simfisis. Terpendek dan terpenting: minimal 10 cm.

Konjugata diagonalis

Ke tepi bawah simfisis. Satu-satunya yang dapat diukur klinis: minimal 11,5 cm.

Obstetrika = diagonalis − 1,5 sampai 2 cm

Empat bentuk panggul Caldwell-Moloy



Ginekoid

Bulat; tersering dan paling baik

Android

Segitiga; depan sempit

Antropoid

Lonjong muka-belakang

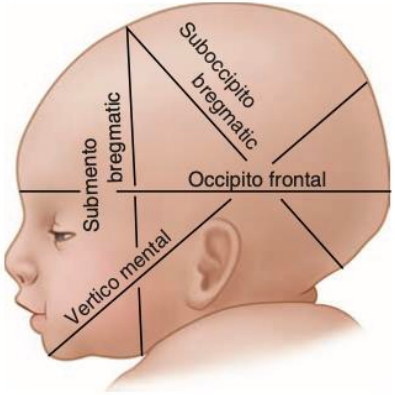
Platipeloid

Pipih; konjugata pendek

Skema pintu atas panggul: sakrum di atas, simfisis di bawah

Android dan platipeloid paling sering menimbulkan kesulitan persalinan

Diameter kepala janin



B. Anteroposterior diameters.

↳ Paling normal. Presentasi belakang kepala.

Suboksipito-bregmatika **9,5 cm**

Kepala fleksi sempurna (belakang kepala)

Oksipito-frontalis **±11,5 cm**

Defleksi ringan (puncak kepala)

Vertico-oksipitalis **±13 cm**

Presentasi dahi; diameter terbesar

↳ Tdk bisa dilahirkan.

Makin defleksi, makin besar diameter yang lewat

3

Penyebab dan faktor risiko

Jalan lahir yang terlalu sempit, janin yang terlalu besar, atau keduanya

Penyebab dari ibu dan dari janin



Dari ibu (passage)

- Panggul sempit: pintu atas, tengah, atau bawah
- Bentuk panggul android atau platipeloid
- Deformitas: fraktur, rakitis, kifoskoliosis
- Tumor yang menghalangi jalan lahir



Dari janin (passenger)

- Makrosomia
- Hidrosefalus atau kelainan kepala lain
- Malposisi: oksiput posterior, asinklitismus
- Defleksi: presentasi dahi atau muka

Faktor risiko yang dikenali saat antenatal

- Tinggi badan kurang dari 145 cm
- Riwayat persalinan macet, seksio sesarea atas indikasi CPD, atau bayi besar
- Riwayat trauma, operasi, atau penyakit tulang panggul dan tulang belakang
- Diabetes, obesitas, atau kenaikan berat badan berlebih: risiko makrosomia
- Tinggi fundus atau taksiran berat janin jauh di atas usia kehamilan

Tanda khas

Kepala belum masuk panggul

Pada primigravida aterm, kepala yang masih melayang perlu dievaluasi: CPD, plasenta previa, atau malposisi.

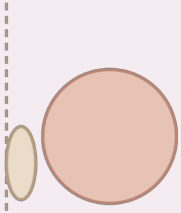
4

Pemeriksaan dan diagnosis

Dari kecurigaan antenatal sampai bukti saat persalinan

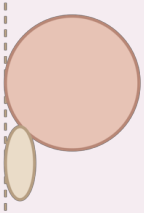
↱ Pertama lakukan pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, 4

Pemeriksaan luar: apakah kepala dapat masuk



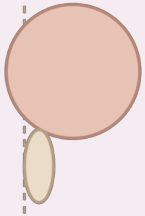
Tidak menonjol

Kepala masuk di belakang simfisis



Sejajar

Kepala rata dengan simfisis: ragu



Menonjol

Kepala di depan simfisis: curiga CPD

Perasat Osborn: raba apakah kepala menonjol di atas simfisis.

Muller-Munro Kerr: dorong kepala ke panggul sambil menilai tumpang tindih di simfisis.

PEMERIKSAAN LEOPOLD



Leopold I

- Fundus uteri
- Bagian teratas/ terbawah janin



Leopold II

- Arah punggung janin
- Ekstremitas



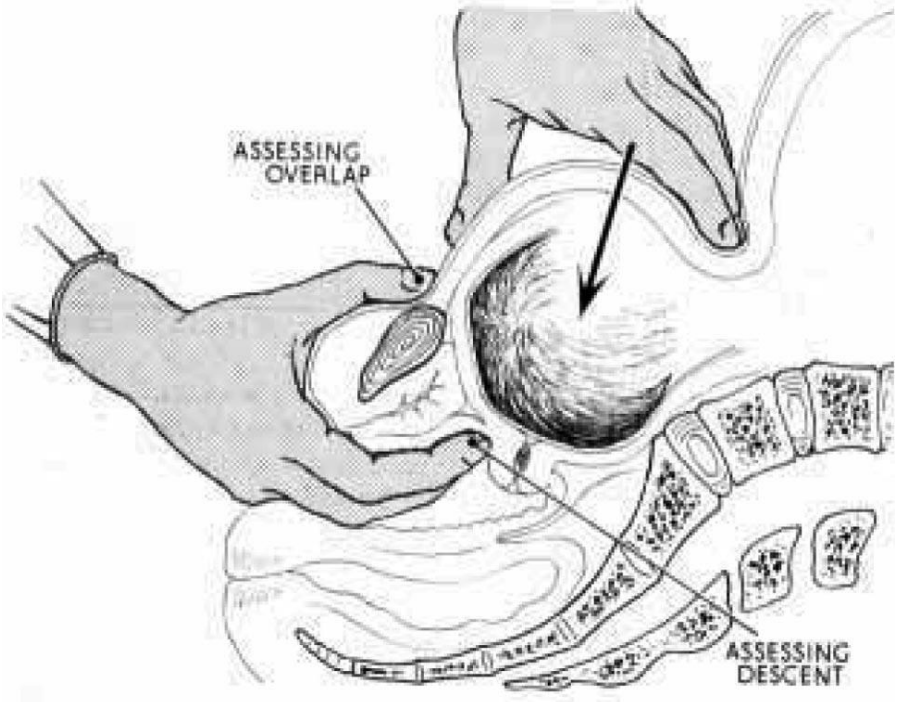
Leopold III

- Bagian fetus yang masuk PAP
- Mobilitas janin



Leopold IV

- Seberapa jauh janin masuk PAP
- Konvergen/ divergen



Disproporsi sefalopelvik (CPD)

Pelvimetri klinis saat pemeriksaan dalam

1 Promontorium

Teraba atau tidak; ukur konjugata diagonalis

2 Linea innominata

Normal hanya teraba sepertiga depan

3 Dinding samping

Sejajar atau konvergen

4 Spina iskiadika

Menonjol atau tidak; perkirakan interspinarum

5 Sakrum → Jgn sampe tidak menonjol

Cekung atau datar; mobilitas koksigeus

6 Arkus pubis

Sudut lebih dari 90°; intertuberosum lebar

Pelvimetri klinis mengenali panggul yang jelas sempit; tidak dapat memastikan panggul cukup

Peran pencitraan: terbatas → tdk dianjurkan utk pencitraan

RR 1,34

seksio sesarea lebih sering pada ibu yang menjalani pelvimetri rontgen

tanpa perbaikan luaran perinatal yang jelas

Cochrane, Pattinson dkk., 2017

USG

Taksiran berat janin, presentasi, posisi, hidrosefalus. Galat taksiran berat sekitar 15%.

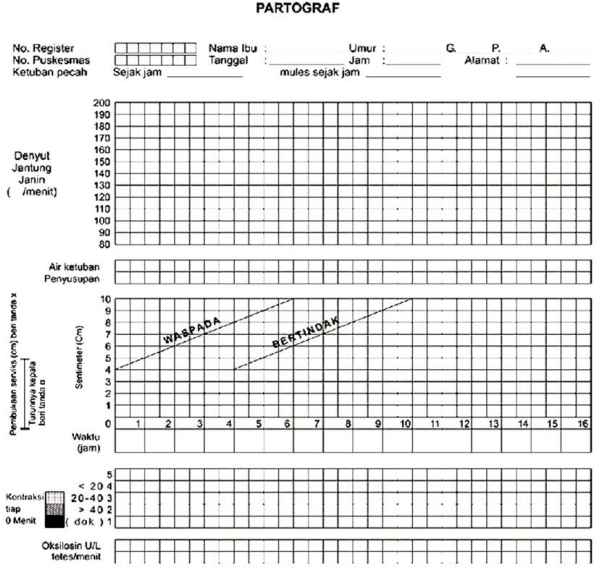
Pelvimetri rontgen, CT, MRI

Tidak rutin. Dipertimbangkan pada riwayat fraktur atau deformitas panggul.

Kemajuan persalinan

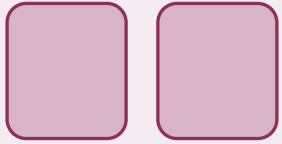
Penilai terbaik kesesuaian kepala dan panggul.

Partograf: bukti saat persalinan



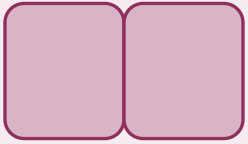
1. Kurva melewati garis waspada: evaluasi ulang dan siapkan rujukan.
2. Mencapai garis bertindak: harus ada keputusan tindakan.
3. His adekuat tetapi pembukaan dan penurunan kepala tidak maju: curiga CPD.

Tanda persalinan macet: molase dan lainnya

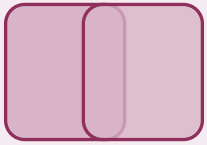


0

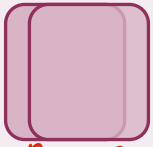
Sutura terpisah



Tulang bersentuhan



Tumpang tindih, dapat dipisahkan



Tumpang tindih berat, menetap → tanda CPD

Tanda lain yang harus dicari

- Kaput suksedaneum besar
- Kepala tidak turun walau his kuat
- Serviks edema, pembukaan tidak maju
- Cincin retraksi Bandl
- Hematuria, kandung kemih penuh
- Ibu kelelahan, DJJ abnormal

Menegakkan diagnosis CPD

1 Curiga

Faktor risiko, kepala belum masuk, perasat Osborn positif

2 Nilai panggul

Pelvimetri klinis; USG untuk berat dan sikap kepala

3 Nilai kemajuan

Partograf: pembukaan, penurunan, molase, his

4 Simpulkan

His adekuat, tetap tidak maju, ada tanda obstruksi

Henti fase aktif (ACOG 2024)

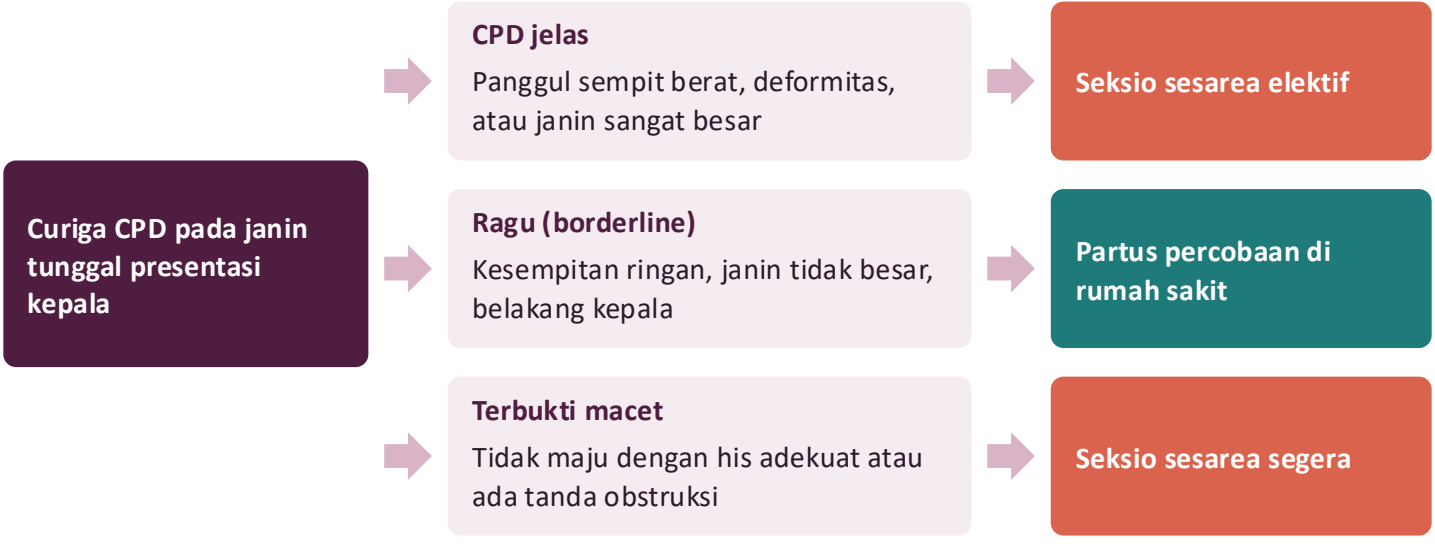
Pembukaan 6 cm atau lebih dan ketuban pecah, tanpa kemajuan setelah 4 jam his adekuat atau 6 jam oksitosin dengan his tidak adekuat.

5

Tatalaksana

Seksio sesarea elektif, partus percobaan, dan hal yang harus dihindari

Alur keputusan tatalaksana



Partus percobaan

Syarat

- Presentasi belakang kepala
- Kesempitan ringan
- Janin tidak besar
- Siap seksio sesarea

Pemantauan

- Partograf ketat
- His dan DJJ
- Penurunan kepala dan molase
- Keadaan umum dan hidrasi ibu

Hentikan bila

- Tidak maju walau his adekuat
- Molase berat, kepala tetap tinggi
- Gawat janin
- Ancaman ruptur uteri

Partus percobaan gagal bukan kegagalan penolong: itu adalah diagnosis CPD

Yang harus dihindari pada CPD

Oksitosin pada obstruksi

Menambah his pada hambatan mekanis berisiko ruptur uteri.

Dorongan fundus

Tidak membantu dan berisiko cedera ibu dan janin.

Vakum atau forseps pada kepala tinggi

Tidak boleh bila kepala belum masuk panggul.

Menunggu terlalu lama

Persalinan macet yang lama berujung ruptur dan fistula.

Komplikasi bila tidak dikenali



Ibu

- Ruptur uteri
- Perdarahan pascapersalinan
- Infeksi intrapartum dan sepsis
- Fistula vesikovagina atau rektovagina
- Trauma jalan lahir



Janin dan bayi

- Asfiksia
- Perdarahan intrakranial
- Sefalhematoma, fraktur tulang kepala
- Infeksi neonatal
- Kematian perinatal

Peran dokter di layanan primer

Lakukan

- Skrining faktor risiko sejak ANC
- Rencanakan persalinan di rumah sakit bila berisiko
- Isi partograf pada setiap persalinan
- Rujuk saat kurva melewati garis waspada

Hindari

- Memimpin persalinan risiko tinggi di fasilitas primer
- Memberi oksitosin untuk persalinan tidak maju
- Dorongan fundus
- Merujuk setelah ibu kelelahan atau gawat janin

Pesan kunci

1. CPD adalah soal kesesuaian kepala dan panggul, bukan ukuran panggul saja.
2. CPD relatif akibat malposisi atau defleksi lebih sering daripada CPD absolut.
3. Pelvimetri hanya menimbulkan kecurigaan; persalinan yang membuktikan.
4. Partograf, penurunan kepala, dan molase adalah alat diagnosis utama.
5. Persalinan macet: jangan oksitosin, jangan dorong fundus; rujuk untuk seksio sesarea.

Referensi

1. Cunningham FG, et al. Williams Obstetrics, edisi 26. McGraw-Hill; 2022. Bab Abnormal Labor.
2. ACOG. First and Second Stage Labor Management. Clinical Practice Guideline No. 8. Obstet Gynecol 2024.
3. Pattinson RC, et al. Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term for deciding on mode of delivery. Cochrane Database Syst Rev 2017; CD000161.
4. WHO. Managing Complications in Pregnancy and Childbirth, edisi 2. Geneva: WHO; 2017.
5. WHO. Labour Care Guide: User's Manual. Geneva: WHO; 2020.
6. Global Library of Women's Medicine (GLOWM). Abnormal Labor: Diagnosis and Management.
7. Prawirohardjo S. Ilmu Kebidanan, edisi 4. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Semua gambar adalah skema ilustratif, tidak berskala.